

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENFERMAGEM E SAÚDE COLETIVA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM**

CAMILA ROCHA SILVEIRA

**TRAJETÓRIA ASSISTENCIAL DA PESSOA COM SÍFILIS GESTACIONAL:
ESTUDO DE COORTE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS**

PORTO ALEGRE

2026

CAMILA ROCHA SILVEIRA

**TRAJETÓRIA ASSISTENCIAL DA PESSOA COM SÍFILIS GESTACIONAL:
ESTUDO DE COORTE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS**

Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Enfermagem.

Área de concentração: Prevenção e cuidado de agravos transmissíveis na Atenção Primária à Saúde

Linha de pesquisa: Enfermagem e Saúde Coletiva

Orientadora: Dra^a Deise Lisboa Riquinho

Coorientadora: Dra^a Stela Maris de Jesus Castro

PORTO ALEGRE

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Silveira, Camila Rocha

TRAJETÓRIA ASSISTENCIAL DA PESSOA COM SÍFILIS
GESTACIONAL: ESTUDO DE COORTE NO MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE/RS / Camila Rocha Silveira. -- 2026.

124 f.

Orientador: Deise Lisboa Riquinho.

Coorientador: Stela Maris De Jesus Castro.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Sífilis. 2. Saúde Materna. 3. Atenção Primária à
Saúde. 4. Desigualdades de Saúde. 5. Saúde Coletiva.
I. Riquinho, Deise Lisboa, orient. II. Castro, Stela
Maris De Jesus, coorient. III. Título.

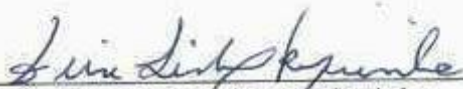
Camila Rocha Silveira

**TRAJETÓRIA ASSISTENCIAL DA PESSOA COM SÍFILIS GESTACIONAL:
ESTUDO DE COORTE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS**

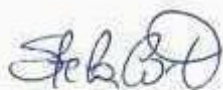
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Enfermagem.

Aprovada em Porto Alegre, 26 de março de 2026.

BANCA EXAMINADORA



Profa. Dra. Deise Lisboa Riquinho
Presidente da Banca – Orientadora
PPGENF/UFRGS



Profa. Dra. Stela Maris de Jesus Castro
Coorientadora
Departamento de Epidemiologia - UFRGS



Profa. Dra. Daila Alena Raenck da Silva
Membro da banca
Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS



Profa. Dra. Fernanda Peixoto Cordova
Membro da banca
HCPA



Profa. Dra. Idiane Rosset
Membro da banca
PPGENF/UFRGS

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço à minha família: minha mãe Naide, meu pai Rogério e meu irmão Eduardo. O apoio incondicional deles foi fundamental para construir minha trajetória. Graças à presença deles e ao incentivo de cada um, o desenvolvimento desta dissertação e todo o percurso do mestrado se tornaram mais leves e significativos. Não somente os agradeço, mas também dedico esse trabalho e toda a minha jornada a eles.

Ao meu namorado, Christoffer, que me apoia em todas as minhas decisões, meu profundo agradecimento. Desde o momento em que compartilhei com ele o desejo de iniciar o mestrado, ele foi a primeira pessoa a me incentivar e acreditar em mim. Ele, há quase 10 anos do meu lado, foi muito importante nesse ciclo, e continuará sendo em todos que estão por vir.

Minha gratidão à minha tia Rosane, ao meu padrinho Gelson e à minha avó Noelzi, cujo carinho, apoio e incentivo foram pilares importantes na minha trajetória.

Agradeço imensamente à minha orientadora, Deise, pela acolhida, pelo cuidado, pela ajuda e (principalmente) pela paciência durante esses dois anos. Ter uma orientadora que escuta, guia e apoia é um privilégio que faz toda a diferença nesse processo.

Agradeço à minha coorientadora, Stela, que desde a primeira reunião me ensinou muito e me guiou com dedicação ao longo de todo esse ciclo.

Agradeço, ainda, a todos os profissionais de saúde que tive a oportunidade de conhecer durante minha jornada na Atenção Primária. Cada encontro foi uma oportunidade de aprendizado, e, sem dúvida, vocês semearam em mim valiosos conhecimentos, tornando-se parte essencial desta caminhada.

Por fim, agradeço a todos os usuários e usuárias dos serviços de saúde nos quais atuei. Cada pessoa foi fundamental para me tornar a profissional que sou hoje. Cada indivíduo que cruza nossa trajetória, independentemente do papel que desempenhe, deixa sua marca e se torna importante no processo. Cada paciente que encontrei, que atendi, que escutei ou que orientei, cada consulta realizada, contribuiu de maneira essencial para minha aprendizagem e crescimento profissional.

“O cuidado não chega da mesma forma para todas, e muitas vezes se perde no caminho entre quem precisa e quem pode oferecer.”

- inspirado em TRAVASSOS & CASTRO (2012), Políticas e sistema de saúde no Brasil.

RESUMO

Introdução: A verificação das Trajetórias Assistenciais destaca os movimentos de cuidado sob a perspectiva dos usuários e dos profissionais de saúde, permitindo uma compreensão mais ampla da experiência do adoecimento. **Objetivo:** Identificar fatores associados às Trajetórias Assistenciais de pessoas que realizaram o acompanhamento pré-natal, receberam o diagnóstico de sífilis durante os atendimentos e foram notificadas para sífilis gestacional, entre 2016 e 2024, sob a perspectiva dos registros dos profissionais de saúde, com base em dados disponíveis em prontuários, no município de Porto Alegre/RS. **Método:** Trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectiva. A identificação da população inicial pelas fichas de notificação de sífilis gestacional no município, resultou em 7.282 gestantes elegíveis. Após a aplicação dos critérios de inclusão previamente estabelecidos, a amostra final foi composta por 524 gestantes para análise de prontuário. Para assegurar a confiabilidade e a transparência na elaboração deste estudo observacional, foi seguido o checklist STROBE. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários estruturados. Os dados coletados foram digitados e armazenados em planilha do Microsoft Excel®, submetidos a processo de validação e, posteriormente, exportados para o software R, versão 4.2.2. As estimativas dos riscos relativos de ocorrência de trajetória inadequada foram obtidas por meio do ajuste de um modelo de regressão de Poisson multivariável, com variância robusta. **Resultados:** A Trajetória Assistencial caracteriza-se predominantemente por mulheres de raça/cor branca (56,1%), ensino fundamental completo (14,7%), idade entre 20 e 29 anos (65,3%), diagnóstico por testagem rápida até a 12ª semana gestacional (50,8%), tratamento com penicilina benzatina (98,4%), que apresentaram menos exames de *Venereal Disease Research Laboratory* (VDRL) do que o preconizado (75,4%) e com baixa testagem da parceria sexual (53,2%). Nas Trajetórias Inadequadas (86,6%), predominam gestantes de raça/cor preta e parda e de menor escolaridade. O risco de desenvolver uma Trajetória Inadequada foi relacionado ao não questionamento da existência de parceiro sexual com acréscimo em 11%; não ter registro do VDRL apresentou aumento em 26%; manter a titulação inalterada ao longo do acompanhamento com incremento em 20%; cada aumento de uma semana na idade gestacional da primeira consulta de pré-natal esteve associado a cerca de 1% a mais no risco de trajetória inadequada. Observa-se a redução da ocorrência de trajetória inadequada nas gestantes de diversos distritos sanitários do município, vinculadas à prefeitura, em comparação com o distrito sanitário Centro. **Conclusão:** embora que as Trajetórias Assistenciais foram, em sua maioria, classificadas como inadequadas, há disparidade em relação à raça/cor e escolaridade, sugerindo iniquidades no acesso, diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional. Evidencia-se a compreensão ampliada sobre os fatores associados à sífilis materna, destacando lacunas no rastreamento e no acompanhamento pré-natal, e fornecendo subsídios para futuros planejamentos em saúde.

Palavras-Chave: Sífilis; Saúde Materna; Atenção Primária à Saúde; Desigualdades de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: The assessment of Care Trajectories highlights patterns of care from the perspectives of both users and healthcare professionals, enabling a broader understanding of the experience of illness. **Objective:** To identify factors associated with the Care Trajectories of individuals who underwent prenatal care, received a diagnosis of syphilis during care, and were reported as gestational syphilis cases between 2016 and 2024, from the perspective of healthcare professionals' records, based on data available in medical charts, in the municipality of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. **Method:** This is a retrospective cohort study. The initial population was identified through gestational syphilis notification forms in the municipality, resulting in 7,282 eligible pregnant women. After applying previously established inclusion criteria, the final sample consisted of 524 pregnant women for medical record analysis. To ensure reliability and transparency in the development of this observational study, the STROBE checklist was followed. Data collection was carried out *באמצעות* structured questionnaires. The collected data were entered and stored in Microsoft Excel® spreadsheets, underwent a validation process, and were subsequently exported to R software, version 4.2.2. Estimates of the relative risks of inadequate trajectories were obtained by fitting a multivariable Poisson regression model with robust variance. **Results:** Care Trajectories were predominantly characterized by women who self-identified as White (56.1%), had completed elementary education (14.7%), were aged between 20 and 29 years (65.3%), received a diagnosis through rapid testing up to the 12th gestational week (50.8%), and were treated with benzathine penicillin (98.4%). However, fewer Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) tests than recommended were observed (75.4%), along with low rates of partner testing (53.2%). In inadequate trajectories (86.6%), there was a predominance of Black and Brown women and those with lower levels of education. The risk of developing an inadequate trajectory was associated with not questioning the existence of a sexual partner (11% increase), absence of VDRL records (26% increase), unchanged titers throughout follow-up (20% increase), and each additional week of gestational age at the first prenatal visit (approximately 1% increase in risk). A reduction in the occurrence of inadequate trajectories was observed among pregnant women from various municipal health districts linked to the city administration, compared with the Central Health District. **Conclusion:** Although most Care Trajectories were classified as inadequate, disparities related to race/skin color and education level were identified, suggesting inequities in access to diagnosis and treatment of gestational syphilis. The findings provide an expanded understanding of factors associated with maternal syphilis, highlighting gaps in screening and prenatal follow-up, and offering evidence to support future health planning.

Keywords: Syphilis; Maternal Health; Primary Health Care; Health Inequalities.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS	Atenção Primária à Saúde
DS	Distritos Sanitários
DSS	Determinantes Sociais de Saúde
ESF	Estratégia e Saúde da Família
GHC	Grupo Hospitalar Conceição
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
IST	Infecção Sexualmente Transmissível
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
NV	Nascidos Vivos
OMS	Organização Mundial da Saúde
Sinan	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SMS/POA	Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
SPSS	<i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
STROBE	<i>Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology</i>
UI	Unidades Internacionais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 OBJETIVOS	21
2.1 Geral	21
2.2 Específicos	21
3 MÉTODO	22
3.1 Tipo de estudo	22
3.2 Campo de estudo	22
3.3 Participantes	23
3.4 Coleta de dados	27
3.5 Análise de dados	30
3.6 Considerações éticas	31
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
REFERÊNCIAS	34
APÊNDICE A - COLETA DE DADOS DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO	38
APÊNDICE B - COLETA DE DADOS REFERENTES À IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS TRAJETÓRIAS ASSISTENCIAIS	40
APÊNDICE C - COLETA DE DADOS EM RELAÇÃO À PARCERIA SEXUAL	42
APÊNDICE D - PARECER CONSUBSTANCIADO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA	43

1 INTRODUÇÃO

A escolha deste tema foi motivada pela minha experiência como enfermeira atuante na área da Saúde Coletiva, desde a minha formação na graduação e residência em Saúde Comunitária até minha atuação profissional em um Serviço de Atenção Primária em Porto Alegre. Ao longo da minha jornada na Atenção Primária à Saúde (APS), me deparei com diversos casos de sífilis gestacional e percebi que, mesmo com a realização das consultas de pré-natal e a disponibilidade do tratamento, muitos casos não tiveram desfecho satisfatório, evidenciando desafios no sucesso terapêutico.

Diante disso, busquei compreender melhor a Trajetória Assistencial das gestantes com sífilis e identificar os principais desafios que dificultam um acompanhamento efetivo, a partir da perspectiva dos registros dos profissionais de saúde, buscando evidenciar possíveis incompletudes no diagnóstico, tratamento e acompanhamento. A partir dessa análise, pretende-se fornecer subsídios para a educação continuada dos profissionais, além de contribuir para o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a captação precoce para o pré-natal e a garantia de um tratamento adequado para todas as pessoas que vivenciam a sífilis gestacional.

Nesse sentido, as Trajetórias Assistenciais consistem nos movimentos que indivíduos ou grupos percorrem visando preservação, tratamento e recuperação da saúde, considerando o contexto em que se introduzem e o uso de todos os recursos que encontram disponíveis. A sua análise permite o reconhecimento de caminhos traçados pelos usuários dos serviços de saúde, permitindo assim, identificar os cuidados realizados e investigar a resolutividade da rede de atenção em saúde que estão inseridos (Gerhardt, 2016; Argenton *et al.*, 2018).

A verificação das Trajetórias Assistenciais destaca os movimentos subjetivos de cuidado sob a perspectiva dos usuários e/ou dos profissionais de saúde, permitindo uma compreensão mais ampla da experiência do adoecimento. Isso abrange não apenas a prescrição do tratamento, mas também as características sociais e culturais envolvidas, que influenciam os complexos processos de escolha da realização de um cuidado. Refletem as decisões dos usuários ao buscar atendimento nos serviços de saúde e ao aderir às recomendações e prescrições oferecidas pelos profissionais. Esse processo evidencia a influência de fatores individuais, sociais e estruturais na adesão ao cuidado e no acesso aos serviços de saúde (Gerhardt, 2016; Argenton *et al.*, 2018).

A compreensão das Trajetórias Assistenciais reforça não apenas as experiências individuais das pessoas na busca do cuidado, mas também em observar a assistência produzida pelos usuários e também pelos profissionais da rede de saúde. Isso implica que os modelos de atenção, muitas vezes idealizados em sua base teórica, ganham forma na prática diária, por meio das ações de diferentes sujeitos. Cada um desses atores contribui com seu repertório de saberes e vivências, resultando em um conjunto diversificado de práticas, que dão origem a novos roteiros e formas de cuidado, adaptadas às realidades específicas de cada um desses usuários (Gerhardt, 2016; Argenton *et al.*, 2018; Kessler; Ruiz; Schuch, 2023).

Causada pela bactéria *Treponema pallidum*, a sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), e que apesar de possuir um tratamento eficaz, baixo custo e que está disponível na APS, vem-se mantendo como um problema de saúde pública e social até os dias atuais (Brasil, 2022a). O agravo pode apresentar diversas manifestações clínicas e evoluir por diferentes estágios: primário, secundário, terciário e latente, com alterações na infecção e no risco de transmissão (Schlueter *et al.*, 2022).

A sífilis gestacional ocorre quando a pessoa adquire a infecção durante qualquer estágio da gestação, parto ou puerpério, podendo ser transmitida verticalmente, da mãe para o feto, representando um sério risco à saúde materno fetal, expondo-se a possíveis desfechos negativos. Entre as complicações associadas à sífilis congênita, destacam-se o aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer, malformações fetais e infecções neonatais, que podem ser assintomáticas ou apresentar manifestações clínicas graves (Rocha *et al.*, 2021).

Em relação à saúde materna, a infecção não tratada pode evoluir para formas mais severas, comprometendo o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, além de que, a presença da sífilis aumenta a vulnerabilidade a outras ISTs. Diante desses riscos, é fundamental garantir o acompanhamento adequado das gestantes e de suas parcerias sexuais, priorizando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da infecção (Brasil, 2022a; Schlueter *et al.*, 2022).

Em 2020, o Ministério da Saúde implementou novas estratégias para o monitoramento e vigilância da sífilis gestacional, com o objetivo de reduzir os casos e prevenir a sífilis congênita. Essas ações incluíram o aumento da oferta de testes rápidos, a disponibilização do tratamento com benzilpenicilina para gestantes e suas parcerias sexuais, além da ampliação do acesso aos serviços no âmbito da APS (Brasil, 2021). A integração dessas medidas, que

englobam o rastreamento e tratamento da sífilis durante o acompanhamento pré-natal, fortalecem as chances de sucesso no combate à sífilis gestacional e congênita, consequentemente reduzindo a exposição do feto ao *Treponema pallidum* (Paula *et al.*, 2022).

A abordagem da saúde materno-infantil tem como uma das suas etapas a realização do pré-natal, protagonista nessa atenção, que, quando realizado de forma adequada e qualificada, identifica as principais alterações desse período, visando evitar complicações ligadas à gestação e a reduzir os níveis de óbitos maternos e fetais. A recomendação é que o pré-natal de risco usual, seja desenvolvido na APS, pelas equipes de Estratégia e Saúde da Família (ESF), envolvendo a realização das consultas, solicitação de exames, orientações sobre parto e puerpério, imunização, e, além de outros, a realização de testes para identificação de ISTs (Brasil, 2013).

Durante a gestação, a ocorrência de eventos adversos é 52% maior entre mulheres diagnosticadas com sífilis gestacional. Diante disso, é fundamental que os serviços de saúde reforcem os fluxos e protocolos assistenciais, incluindo a busca ativa de gestantes, visitas domiciliares, o acompanhamento de parceiros sexuais, a integração do planejamento familiar ao pré-natal, e a vigilância em saúde. Além disso, deve-se priorizar o atendimento a mulheres em situação de risco e extrema vulnerabilidade (Macêdo *et al.*, 2020; Marques *et al.*, 2021).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no período de 2016 a 2017, 95 países apresentaram casos de resultados de testes positivos para sífilis, dentre eles 16 não registraram casos entre mulheres grávidas. Nos 76 países que reportaram dados sobre sífilis gestacional no período, a cobertura média do tratamento durante consultas pré-natais foi de 99,6%, variando entre 16,7% e 100%. No entanto, a proporção de tratamento alcançou 100% em todas as regiões, com exceção das Américas e do Sudeste Asiático, que apresentaram variações nas taxas de tratamento (WHO, 2017).

O número estimado de novos casos de sífilis entre adultos de 15 a 49 anos no mundo aumentou de 7,1 milhões em 2020 para uma média de 8,0 milhões em 2022. Nesse mesmo ano, foram registrados cerca de 390 mil desfechos adversos associados à sífilis materna. Desses casos, 21% ocorreram entre gestantes que não realizaram acompanhamento pré-natal (WHO, 2021).

Em relação aos dados nacionais, mesmo com todos os avanços na detecção da sífilis, os números índices de sífilis gestacional e congênita seguem aumentando. Conforme Boletim

Epidemiológico de Sífilis (Brasil, 2025), em 2024 foram notificados 89.724 casos de sífilis gestacional em todo o Brasil, com uma taxa de detecção de 35,4 casos por 1.000 Nascidos Vivos (NV), com 13,8% dos casos na região Sul. No país, entre 2014 e 2024, embora se observe tendência crescente da média móvel dos casos, a partir de 2023 verificou-se desaceleração desse crescimento. Ainda em 2024, o Rio Grande do Sul foi um dos estados com as maiores taxas de detecção, com 40,9 casos por 1.000 NV.

Conforme o Boletim Epidemiológico de 2024, no município de Porto Alegre/RS, no respectivo ano foram notificados 765 casos de sífilis em gestantes. Ao analisar a taxa de detecção, os anos de 2022 e 2023 apresentaram decréscimo em relação aos anos 2020 e 2021, entretanto, em 2024 a taxa voltou a subir, sugerindo uma possível retomada da transmissão da sífilis gestacional na população (Porto Alegre, 2025).

Os casos da sífilis gestacional podem estar relacionados à fragilidade do sistema de saúde pública e à insuficiência das ações de assistência no pré-natal. Os métodos de diagnóstico da sífilis são conhecidos há mais de um século, e a penicilina tem sido utilizada no tratamento há cerca de 80 anos. Esses fatores evidenciam que a persistência da sífilis gestacional e congênita está associada a um pré-natal inadequado ou incompleto, geralmente iniciado após a 12ª semana de gestação. Além disso, pode estar relacionada a falhas no tratamento e acompanhamento, seja pela conduta profissional inadequada, como a não administração do tratamento conforme a fase da doença, ou pela interrupção do tratamento por parte da gestante (Torres *et al.*, 2022; Eksélius; Gerdin; Vahlquist, 2024).

A alta prevalência do agravo no país também está ligada ao contexto social das gestantes. O Brasil, um dos mais desiguais do mundo, com baixos níveis de educação e com uma visão estigmatizada e conservadora sobre saúde sexual e reprodutiva, portanto, a promoção de estratégias de educação em saúde à população e educação permanente aos profissionais, ajudará a minimizar barreiras e promover menor transmissão da sífilis (Domingues; Szklo, 2013; Soares, 2022).

Estudos realizados no Rio Grande do Sul, revelaram que mulheres negras, em geral, realizam um menor número de consultas pré-natais e iniciam o acompanhamento de forma tardia. Além disso, essas mulheres tendem a residir em locais mais distantes dos serviços de saúde e geralmente enfrentam barreiras socioeconômicas, como a falta de recursos para transporte e a perda de horas de trabalho, além de fatores educacionais e culturais que dificultam

o acesso a um pré-natal de melhor qualidade, incluindo a testagem sorológica para sífilis (Silva, 2018; César, 2020).

Além deste, outros estudos nacionais reforçam que, especificamente na realização da consulta pré-natal, gestantes adolescentes e negras recebem atendimento assistencial de menor qualidade em relação às mulheres brancas, o que evidencia a persistência do racismo institucional nos serviços de saúde e no acesso ao cuidado gestacional (Cesar *et al.*, 2011; Luz; Aquino; Medina, 2018). Em concordância a isso, a cobertura das consultas pré-natais de mulheres indígenas é inferior à de mulheres não indígenas, com ênfase na região do Norte e Nordeste. Além destes, são identificados como as principais fragilidades de acesso à infraestrutura precária dos serviços, tempo de consulta escassos, exames complementares insuficientes, número de consultas inadequadas e pouca captação precoce das gestantes (Luz; Aquino; Medina, 2018; Silva, 2019).

Um estudo realizado nos Estados Unidos no ano de 2021 destacou que a literatura sobre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) aponta que pessoas em situação de vulnerabilidade social e privação econômica têm menor probabilidade de acessar os cuidados de saúde necessários. Nesse contexto, oferecer suporte adicional a gestantes socialmente vulneráveis e em situação de risco é essencial para reduzir os casos de sífilis congênita associados à vulnerabilidade materna e ao contexto social (Chan *et al.*, 2021).

Mesmo entre as mulheres que realizam e possuem acesso ao pré-natal, há inúmeras oportunidades perdidas no diagnóstico e tratamento da sífilis. A remoção de barreiras para a realização de um pré-natal adequado envolve diversos fatores, incluindo a captação precoce da gestante, o aconselhamento pré-natal, educação em saúde, a solicitação e realização de exames conforme os protocolos, a obtenção dos resultados em tempo oportuno e o tratamento da sífilis realizado de forma adequada pela gestante, e se possível e necessário, de seu parceiro (Farias *et al.*, 2021; Lima *et al.*, 2021).

Estudos Nacionais e Internacionais, reforçam a importância da captação precoce da gestação, rastreamento da sífilis em mais de um momento durante as consultas de pré-natal, sendo a primeira testagem na primeira consulta, priorizar a testagem em gestantes de menor nível socioeconômico, mulheres da cor da pele preta e as que pouco aderem às consultas de pré-natal (Warren *et al.*, 2018; Silva, 2019; Cesar *et al.*, 2020).

Esses fatores contribuem para a construção de Trajetórias Assistenciais adequadas no cuidado de gestantes com sífilis, caracterizadas pelo diagnóstico precoce, adesão ao pré-natal, tratamento oportuno e acompanhamento contínuo. Em contrapartida, as Trajetórias Assistenciais inadequadas estão associadas à captação tardia da gestante, à baixa adesão às consultas e recomendações, além de dificuldades no seguimento do cuidado durante a gestação, o que compromete a efetividade do manejo da doença.

A criação de programas pré-natais efetivos, que se adequem ao contexto social das gestantes, e o gerenciamento de casos para pessoas com sífilis podem ajudar a reduzir barreiras ao atendimento em saúde decorrentes de diferenças sociais, culturais e linguísticas, além de incentivar maior adesão e continuidade no cuidado (Abreu *et al.*, 2024; Silva *et al.*, 2024).

Diante do exposto, apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento da sífilis, ainda persistem lacunas relevantes no acompanhamento pré-natal, no rastreamento e seguimento dos casos, bem como na captação e manejo das parcerias sexuais. Nesse contexto, torna-se necessário aprofundar a compreensão dessas fragilidades, a fim de subsidiar o desenvolvimento de intervenções mais eficazes. A partir desta contextualização apresenta-se como questão de pesquisa: Como se caracterizam as Trajetórias Assistenciais de pessoas com sífilis gestacional durante o pré-natal na rede pública de Porto Alegre, no período de 2016 a 2024?

A hipótese do estudo é que gestantes com sífilis pertencentes às categorias de raça/cor preta e parda, com início tardio do pré-natal e diagnóstico tardio da sífilis, que não realizaram tratamento adequado e não tiveram controle mensal do VDRL, apresentando maior probabilidade de desfecho caracterizado por Trajetória Assistencial Inadequada.

2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Identificar fatores associados às Trajetórias Assistenciais de pessoas que realizaram o acompanhamento pré-natal, receberam o diagnóstico de sífilis durante os atendimentos e foram notificadas para sífilis gestacional, entre 2016 e 2024, sob a perspectiva dos registros dos profissionais de saúde, com base em dados disponíveis em prontuários, no município de Porto Alegre/RS.

2.2 Específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

- a) caracterizar o perfil sociodemográfico e as variáveis do acompanhamento da sífilis das gestantes em Trajetória Assistencial Adequada ou Inadequada;
- b) relacionar as trajetórias conforme os distritos sanitários no município estudado.

3 MÉTODO

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa.

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectiva (Hulley, 2015).

Neste trabalho, adota-se a abordagem das Trajetórias Assistenciais como referencial teórico-metodológico. Trata-se de uma metodologia que permite analisar o funcionamento da rede de saúde, contemplando aspectos como a organização dos serviços e as lacunas nos processos de acompanhamento dos usuários. As Trajetórias Assistenciais focalizam o percurso realizado pelos indivíduos nos serviços de saúde, possibilitando a compreensão das interações e fluxos na rede assistencial. Em contraste, as Trajetórias Terapêuticas (ou Itinerários Terapêuticos) apresentam um escopo mais abrangente que não se restringe a um espaço específico (Gerhardt, 2016; Argenton *et al.*, 2018). Essa distinção fundamenta a escolha da abordagem adotada neste estudo.

3.2 Campo de estudo

O estudo foi realizado na cidade de Porto Alegre/RS, utilizando os dados disponíveis nos prontuários eletrônicos dos usuários sobre sífilis gestacional. As fichas de notificação individual do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) de sífilis gestacional foram utilizadas para a seleção dos participantes da pesquisa.

O município de Porto Alegre implementou o sistema e-SUS em 2013 com o objetivo de reestruturar as informações da APS em nível local, alinhando-se à proposta mais ampla do Ministério da Saúde para modernização dos Sistemas de Informação em Saúde, conforme a Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013 (Brasil, 2013). A implantação ocorreu entre 2014 e 2015, e desde o ano de 2016, 100% das unidades vinculadas à prefeitura utilizam o sistema e-SUS (Porto Alegre, 2016).

Conforme o Plano Municipal de Saúde de Porto Alegre (2022-2025), o município conta com 132 unidades de saúde, distribuídas em 17 Distritos Sanitários (DS). Especificamente em relação à APS, há 98 unidades contratualizadas, 21 sob administração própria, 13 conveniadas, além de uma unidade móvel e uma unidade de saúde indígena. Dentre todos os serviços

ofertados no município, cerca de 91% são terceirizados e/ou contratualizados. Todas essas unidades estão envolvidas na realização e no acompanhamento do pré-natal e da sífilis gestacional (Porto Alegre, 2022; Brandes, 2025).

Porém, entre as unidades de saúde que compõem a APS e são conveniadas à prefeitura municipal, sob a gerência do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), não utilizam, ou não utilizavam durante todo o período da pesquisa, o sistema de informação e-SUS, adotando em vez disso um sistema próprio de prontuário eletrônico.

Além disso, Porto Alegre é dividida em 17 DS, que são unidades organizacionais responsáveis pela gestão da APS na cidade, garantindo o acesso à saúde para a população em diversas regiões. Cada distrito abrange uma área geográfica específica e conta com uma rede de serviços de saúde, que visam atender as necessidades da população. A organização desses distritos permite um atendimento mais próximo e eficaz, facilitando a implementação de políticas públicas de saúde e promovendo a equidade no acesso a cuidados médicos no município (Porto Alegre, 2022).

Desde 1986, a sífilis congênita tornou-se uma doença de notificação compulsória, e, em 2005, a sífilis gestacional também foi incluída. No caso da sífilis gestacional, devem ser notificadas todas as pessoas diagnosticadas durante o pré-natal, parto ou puerpério (Brasil, 2007a). A ficha de notificação contém informações gerais, como dados do paciente (nome, idade, sexo, escolaridade e local de residência), além de atributos específicos de cada agravo, permitindo a compreensão do perfil sociodemográfico e clínico de um determinado território. No entanto, o acesso a dados secundários em prontuários eletrônicos possibilita uma análise mais detalhada e aprofundada da assistência prestada à população (Brasil, 2007b).

3.3 Participantes

A população deste estudo foi selecionada a partir dos casos de sífilis gestacional registrados na ficha de notificação individual do Sinan de Porto Alegre/RS, com 7.282 casos notificados disponíveis na vigilância epidemiológica do município, abrangendo o período estipulado na pesquisa. Para a realização deste estudo, os dados da ficha de notificação foram

utilizados na seleção dos participantes, e as informações para a coleta de dados selecionadas a partir dos prontuários eletrônicos.

Conforme Boletim Epidemiológico da Sífilis, no período de 2012 a 2022, foram notificados em todo o Brasil, 537.401 casos de sífilis em gestantes e 238.387 casos de sífilis congênita. No Estado do Rio Grande do Sul, durante o mesmo período, 41.758 casos foram confirmados (Brasil, 2023). Somente em 2024, foram registrados 89.724 novos casos de sífilis em gestantes em todo o Brasil e 24.443 casos de sífilis congênita. As taxas de sífilis congênita passaram a exibir sinais de estabilidade a partir de 2021 com 10,1 casos por 1.000 NV e, em 2024, mostrou uma redução, atingindo 9,6 casos por 1.000 NV, com 12,8% dos casos na região Sul (Brasil, 2025).

São considerados casos de sífilis gestacional as pessoas que, durante o pré-natal, parto ou puerpério, atendam a um dos seguintes critérios: a) estejam assintomáticas e apresentem pelo menos um teste reagente, seja treponêmico e/ou não treponêmico, com qualquer titulação, e não tenham registro de tratamento prévio; b) estejam sintomáticas para sífilis e apresentem pelo menos um teste reagente, seja treponêmico e/ou não treponêmico, com qualquer titulação; c) apresentem teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação, e teste treponêmico reagente, independentemente de sintomatologia ou de tratamento prévio (Brasil, 2017).

Os testes treponêmicos, podendo ser a testagem rápida ou laboratorial, identificam anticorpos específicos contra os antígenos do *Treponema*, podendo apresentar resultados positivos já entre uma e três semanas após o contágio. Esses exames podem permanecer reagentes por toda a vida, o que torna inadequado seu uso no monitoramento de casos ou na investigação de suspeitas de reinfecção, sendo indicados somente para diagnóstico inicial. Já os testes não treponêmicos, também conhecidos como exame VDRL, identificam anticorpos não específicos para o *Treponema*, sendo amplamente utilizados no diagnóstico, monitoramento e controle do tratamento. Os resultados desses testes são expressos em titulações seriadas, tais como 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512, 1:1024, entre outras (Brasil, 2017; 2022b; UFRGS, 2023).

Titulações consideradas baixas, como: 1:2 a 1:8, podem indicar uma infecção recente, uma cicatriz sorológica após tratamento adequado ou até mesmo um falso positivo. Já as médias (1:16 a 1:64) geralmente tendem a sugerir uma infecção ativa, especialmente nas fases recente e secundária da sífilis. Titulações altas (1:128 a 1:1024) são mais comuns na sífilis secundária

ou latente recente e podem indicar infecção em estágio avançado. O acompanhamento da titulação é essencial para avaliar a resposta ao tratamento, sendo esperado que os títulos diminuam progressivamente após o tratamento adequado. Caso os valores permaneçam elevados ou aumentem, pode ser indicativo de falha terapêutica ou reinfecção, exigindo uma nova abordagem clínica (Brasil, 2017; 2021; UFRGS, 2023).

E os casos de cicatriz sorológica ocorrem quando, além do exame não treponêmico permanecer reagente em baixa titulação, o exame treponêmico continua positivo, mesmo após um tratamento adequado, sem necessidade de retratamento. Já os falsos positivos acontecem quando o exame não treponêmico apresenta resultado reagente em baixa titulação, mas o exame treponêmico é não reagente, levando a um diagnóstico incorreto de sífilis (Brasil, 2017; Brasil, 2021).

Dentre os critérios de elegibilidade no estudo, foram incluídas as pessoas gestantes, que:

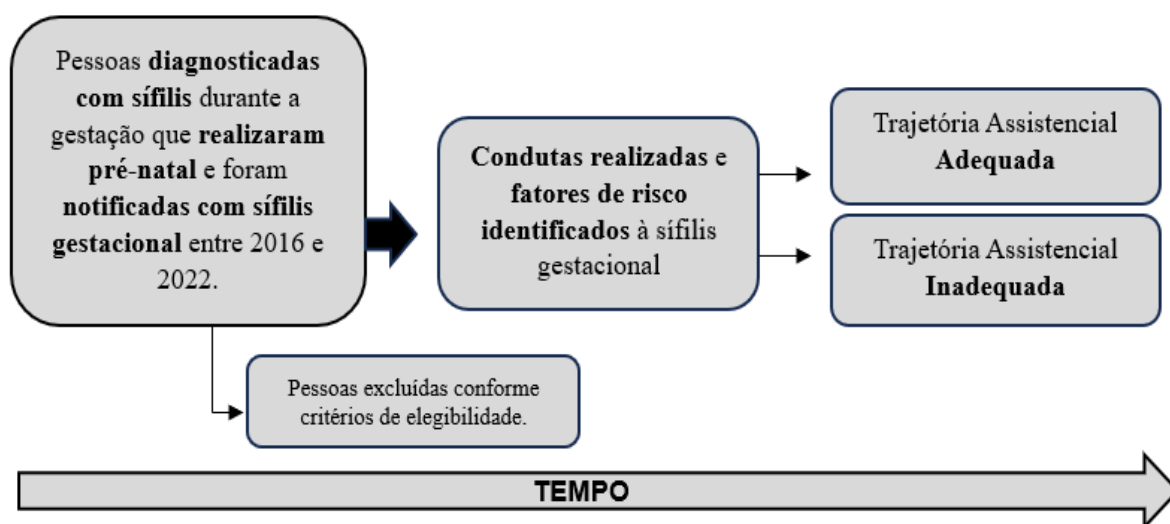
- a) foram notificadas para sífilis gestacional durante o período estipulado da pesquisa;
- b) que residem em Porto Alegre/RS, e que receberam todo o atendimento pré-natal na rede primária à saúde nas unidades vinculadas à prefeitura municipal, no respectivo município;
- c) nos casos em que há necessidade de pré-natal de alto risco, as gestantes devem manter o acompanhamento concomitante na APS, que permanece como o principal foco dos atendimentos e ser o local onde são realizados o acompanhamento e o tratamento da sífilis;
- d) devem apresentar o exame treponêmico reagente e terem o diagnóstico de sífilis ativa durante a gestação, podendo ser um novo caso ou uma reinfecção, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde (Brasil, 2017);
- e) em casos de reinfecção, os exames não treponêmicos devem apresentar resultados reagentes, acima de 1:8, que comprovem um novo caso de sífilis; já em casos de primeiro diagnóstico, não há valor mínimo do VDRL ou necessidade do exame para inclusão na pesquisa.

E, os critérios de exclusão, foram excluídos os participantes que:

- a) o pré-natal foi realizado exclusivamente em serviços de saúde secundários e terciários, incluindo o pré-natal de alto risco;
- b) não foram acompanhadas pelo serviço público de saúde ou as que o acompanhamento foi feito pelas unidades conveniadas à prefeitura;
- c) não realizaram as consultas de pré-natal ou tiveram quantitativos insuficientes de informações registradas. Para este, consideramos no mínimo seis consultas de pré-natal para considerar um quantitativo suficiente, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde;
- d) quanto as gestações notificadas duas vezes ou mais, manteve-se apenas uma única notificação para análise de cada gestação;
- e) apresentaram interrupção da gravidez anterior as 20^o semanas gestacionais, visando o baixo registro de informações pelos números insuficientes de consultas;
- f) aquelas que apresentaram testes falso-positivos para sífilis (com exame treponêmico negativo) ou cicatriz sorológica (foram excluídos os casos de sífilis prévia, anterior ao pré-natal com exame não treponêmico de baixa titulação sendo menor que 1:8 ou não reagente).

A população do estudo está descrita na Figura 1.

Figura 1 - População do estudo.



Fonte: adaptada de Hulley (2015).

Para a seleção dos participantes, foram aplicados os critérios de elegibilidade definidos.

3.4 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários estruturados, que foram respondidos com base nas informações registradas pelos profissionais de saúde nos prontuários eletrônicos dos participantes, disponíveis no sistema *e-SUS APS*. Para reduzir potenciais vieses de informação, foram utilizadas questões fechadas, minimizando a possibilidade de interferência do pesquisador na coleta dos dados. Os prontuários foram previamente selecionados conforme os critérios de elegibilidade do estudo, analisados individualmente, e os dados extraídos sistematizados em uma planilha do *Microsoft Excel*.

Para a coleta e análise dos dados, foi utilizado como base, o manual *TeleCondutas: Sífilis*, elaborado pela TelessaúdeRS-UFRGS em 2023. Este manual contém dados e condutas atualizadas, sendo um consenso entre o manual da Prefeitura de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul e o do Ministério da Saúde. Além disso, oferece informações de fácil acesso, contribuindo para a implementação de condutas adequadas no diagnóstico e manejo da sífilis. Neste material, os termos “adequado” e “inadequado” são utilizados para classificar o acompanhamento e o tratamento com base na prescrição, no tempo de tratamento, na conclusão deste, entre outros fatores. Esses mesmos termos foram adotados neste projeto. Dessa forma, a variável de desfecho corresponde à Trajetória Assistencial binária, cujas categorias de resposta serão “adequada” e “não adequada”.

Para avaliação do perfil sociodemográfico da sífilis gestacional – questionário 1 – (Apêndice B), foram consideradas informações maternas, sendo as seguintes variáveis: raça/cor; idade; escolaridade identificada no cadastro; idade gestacional na primeira consulta; idade gestacional no momento do diagnóstico; idade gestacional por trimestre no momento do diagnóstico; distrito e bairro da unidade de saúde em que realizou o pré-natal; se a gestante foi questionada sobre a existência de parceria sexual; se foi questionada sobre a parceria, se possui parceiro ou não; registro ou não de uma ocupação e sua descrição; e possíveis vulnerabilidades (situação de rua, outras comorbidades, condição prisional, se recebe auxílio do governo, entre outros).

Considerando que as informações sobre escolaridade, bairro e distrito da usuária estão disponíveis no cadastro individual do sistema de coleta de dados, mas podem não estar atualizadas ou não corresponder ao período da pesquisa, foram considerados o bairro e o distrito das unidades onde a gestante realizou as consultas durante o período pré-natal, enquanto a escolaridade foi mantida conforme o dado registrado no cadastro individual, sendo esta considerada a escolaridade mínima da gestante.

A identificação, descrição e avaliação das Trajetórias Assistenciais – questionário 2 – (Apêndice C) de pessoas gestantes com sífilis foram considerados aspectos relacionados ao agravamento, como fatores associados, condutas adotadas, tratamentos realizados e adesão da gestante, entre outros. Com base nessas informações, as trajetórias foram classificadas como adequadas ou inadequadas para o manejo da sífilis gestacional. Sendo assim, os seguintes itens foram analisados: realização do primeiro exame treponêmico para diagnóstico de sífilis no pré-natal; titulação do primeiro exame não treponêmico realizado; classificação clínica da sífilis; tratamento completo da gestante e esquema prescrito; se o tratamento da gestante foi realizado até 30 dias antes do parto; exames não treponêmicos suficientes para controle e monitoramento; necessidade de retratamento, sendo este realizado ou não; ocorrência de eventos adversos durante a gestação e parto. A classificação clínica, por se tratar de um dado definido com base em critérios e análise clínica, foram consideradas as informações registradas na ficha de notificação.

Além desses, também foram avaliados, quando aplicável, o exame, tratamento e adesão da parceria da gestante – questionário 3 – (Apêndice D), sendo analisados: se realizada testagem; tratamento prescrito; parceiro tratado concomitante com a gestante. Esses dados foram analisados de forma complementar, já que as informações referentes à parceria da gestante não foram consideradas para a classificação da trajetória como adequada ou inadequada, visto que este não se considera para definição de caso de sífilis congênita, e devido à possibilidade de grande quantitativo faltante de informações.

Ainda no que se refere à parceria sexual, o questionamento à gestante sobre possuir ou não parceiro integra o perfil epidemiológico, por se tratar de uma informação diretamente relacionada à gestante. Por outro lado, os dados referentes somente ao parceiro, como mencionado anteriormente, não serão incluídos na classificação das Trajetórias Assistenciais.

E, para a classificação desses desfechos, conforme o manual utilizado da TelessaúdeRS-UFRGS de 2023, foi considerada uma Trajetória Assistencial da Sífilis Adequada quando a gestante:

- a) realiza testagem para sífilis na primeira consulta de pré-natal até as 12 semanas gestacionais, ou quando há sífilis prévia, exame não treponêmico no primeiro trimestre;
- b) faz de forma completa o tratamento prescrito com benzilpenicilina benzatina iniciado até 30 dias antes do parto, ou, se necessidade de retratamento, o cumpre no mesmo prazo;
- c) executa exames de VDRL mensalmente, ou de forma considerável para o controle e acompanhamento da titulação, desde o término do tratamento até o parto.

Já uma Trajetória Assistencial da Sífilis Inadequada refere-se às gestantes que, não receberam as orientações e condutas do pré-natal conforme preconizado, ou que não aderiram às recomendações, sendo:

- a) tiveram abandono de tratamento ou o realizaram de forma incompleta;
- b) não realizaram ou não foi solicitado o exame não treponêmico, de forma a poder acompanhar a titulação;
- c) iniciaram o acompanhamento pré-natal com diagnóstico de sífilis após as 12 semanas;
- d) fizeram o tratamento com menos de 30 dias anteriores ao parto;
- e) presença de eventos adversos durante a gestação decorrentes da sífilis gestacional, associados a outros fatores considerados inadequados.

Em casos de sífilis gestacional, recomenda-se iniciar o tratamento imediatamente após o diagnóstico, desde que a gestante não possua histórico de tratamento ou acompanhamento prévio. E, mesmo que o tratamento tenha sido iniciado com base em apenas um teste realizado (treponêmico ou não treponêmico), é fundamental realizar um segundo exame para confirmar o diagnóstico. O tratamento de todas as gestantes deve ser feito com benzilpenicilina benzatina,

em caso de alergia grave à medicação, as gestantes devem ser dessensibilizadas e tratadas com penicilina, seguindo os seguintes esquemas: a) Sífilis primária, secundária e latente recente (duração de até um ano): aplicação de 2,4 milhões de Unidades Internacionais (UI), por via intramuscular, em dose única, sendo 1,2 milhão UI em cada glúteo; b) Sífilis latente tardia (duração superior a um ano), latente com duração ignorada e sífilis terciária: aplicação de 2,4 milhões UI, por via intramuscular (1,2 milhão UI em cada glúteo), semanalmente, durante três semanas, totalizando 7,2 milhões UI (Brasil, 2017; 2022b; UFRGS, 2023).

O tratamento da parceria sexual, embora seja essencial para o controle da sífilis gestacional e para evitar reinfecções após o tratamento, não é considerado um critério epidemiológico para a definição de casos de sífilis congênita. Ainda assim, todas as parcerias sexuais devem ser testadas e avaliadas. Se a gestante teve contato sexual nos últimos 90 dias, a parceria sexual deve receber uma dose de 2,4 milhões de UI de benzilpenicilina benzatina, por via intramuscular, em dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo), mesmo que os testes sejam negativos. Caso o teste da parceria sexual seja reagente ou se o contato sexual ocorreu há mais de 90 dias, o tratamento deve ser ajustado conforme o estágio clínico e a suspeita sorológica da doença (Brasil, 2017; 2022).

Para garantir a qualidade do pré-natal, é essencial que a primeira consulta ocorra até a 12ª semana de gestação, com a realização de testes rápidos para ISTs. É recomendado que ao menos seis consultas sejam conduzidas ao longo da gestação, sendo a investigação da sífilis obrigatória em, pelo menos, dois momentos: na primeira consulta de pré-natal, idealmente no 1º trimestre, no início do 3º trimestre (28ª semanas). A testagem da parceria sexual também é necessária para a identificação e prevenção dos casos. Caso a gestante apresente um exame ou teste reagente para a sífilis gestacional, além de ser indispensável a realização completa do tratamento adequado prescrito, há a necessidade do teste não treponêmico (de titulação) mensalmente para controle de cura até o final da gestação, e após, o seguimento é de forma trimestral até completar um ano de tratamento (Brasil, 2017; Brasil, 2022b; UFRGS, 2023).

3.5 Análise de dados

Os dados coletados foram digitados e armazenados em planilha do *Microsoft Excel®*, submetidos a processo de validação e, posteriormente, exportados para o software R, versão

4.2.2. As variáveis quantitativas foram apresentadas por meio da média e desvio padrão ou, quando adequado, pela mediana e amplitude interquartílica. As variáveis categóricas foram expressas em frequências absolutas e relativas. Ambas constituíram as variáveis preditoras do estudo, relacionadas ao perfil sociodemográfico da gestante e aos aspectos clínicos do agravo já descritos na coleta de dados do estudo.

As estimativas de risco relativo para o desfecho, definido como trajetória inadequada para sífilis gestacional, foram obtidas utilizando um modelo de regressão de Poisson multivariável com variância robusta, permitindo ajustar potenciais fatores de confusão e fornecer medidas de associação livres de potenciais confundimentos entre os fatores de exposição e o desfecho.

Para assegurar a confiabilidade e a transparência na elaboração deste estudo observacional, foi seguido o checklist STROBE (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*), que fornece diretrizes metodológicas para o relato de estudos observacionais, garantindo descrição clara de métodos e resultados (Cuschieri, 2019).

A amostra do estudo foi definida a partir da aplicação dos critérios de elegibilidade na população total disponível. Dessa forma, o tamanho amostral correspondeu ao número de participantes elegíveis, não sendo necessário o uso de cálculo amostral prévio.

Após as exclusões de gestantes que não atendiam aos critérios de elegibilidade para o estudo, o tamanho da amostra final foi 524 gestantes. Para o teste de associação do preditor “Questionado se possui parceria sexual” com o desfecho trajetória, o poder estatístico estimado a partir da utilização do modelo de Regressão de Poisson com variância robusta, considerando $RR=1.11$, nível de significância de 5% e tamanho amostral $n=524$ gestantes, o poder estimado foi 82,2%.

3.6 Considerações éticas

Os aspectos éticos deste estudo seguiram rigorosamente as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa com Seres Humanos, conforme estabelecido na Resolução nº 466/2012 e a resolução nº 674/2022 do Conselho Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde (Brasil, 2012; Brasil, 2022c). Além disso, em conformidade com a Resolução nº 580/2018 (Brasil, 2018a), os resultados obtidos serão discutidos com as equipes da Vigilância

Epidemiológica do município, as instâncias gestoras da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS/POA) e o Conselho Municipal de Saúde, por meio de reuniões previamente agendadas. Ressalta-se, ainda, que o estudo atendeu integralmente às disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo o sigilo e a proteção das informações pessoais dos participantes (Brasil, 2018b).

Visando à devolutiva e à apresentação dos dados ao município, aos profissionais de saúde e à comunidade, os resultados serão divulgados por meio de artigos científicos, apresentações em eventos, principalmente locais, em comitês intersetoriais e em outros espaços, quando houver oportunidade.

Essa pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “Trajetória Assistencial de mulheres com sífilis gestacional e sua associação com sífilis congênita: uma coorte retrospectiva”, aprovado pelo número CAAE 88626325.0.0000.5347 e, o projeto “Incidência e Fatores Associados à Sífilis Congênita em Porto Alegre: Um Estudo de Coorte Retrospectiva” aprovado pelo número CAAE 76974424.0.3001.5338, com aprovação em ambos (Apêndice E).

A pesquisa apresenta riscos mínimos para os participantes, sendo a quebra de confidencialidade um deles. Para proteger a identidade das pessoas envolvidas, seus nomes foram substituídos por códigos. Assim, a privacidade e o anonimato das pacientes foram preservados em todos os materiais gerados durante o estudo.

Os benefícios são indiretos, como ampliação do conhecimento sobre a sífilis gestacional em Porto Alegre, fomentar a educação permanente de profissionais e estratégias para que todas as pessoas com sífilis durante a gestação tenham tratamento adequado.

As informações coletadas serão armazenadas pela pesquisadora por um período de dois anos. Após esse prazo, o instrumento utilizado para a coleta dos dados será devidamente descartado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidencia-se a compreensão ampliada sobre os fatores associados à sífilis materna, destacando lacunas no rastreamento e no acompanhamento pré-natal, e fornecendo subsídios para futuros planejamentos em saúde. Torna-se, portanto, imprescindível o fortalecimento de estratégias de testagem rápida para todas as mulheres em idade fértil e seus parceiros, aliado a programas contínuos de educação sexual e reprodutiva. Políticas de saúde integradas ao setor educacional potencializam os efeitos preventivos, promovendo maior autonomia das gestantes, facilitando a detecção precoce da infecção e contribuindo significativamente para a redução da sífilis congênita. A educação, mais do que apenas a escolaridade formal, constitui um elemento central nas trajetórias de cuidado pré-natal, uma vez que diversos estudos demonstram que a prevenção da sífilis gestacional pode ser iniciada antes do início do acompanhamento pré-natal, a partir do acesso à informação e à conscientização sobre saúde sexual e reprodutiva.

Reforça-se a necessidade de políticas eficazes de pré-natal, com equipes da APS preparadas e qualificadas não apenas para atender a gestante com sífilis, mas também para abordar a parceria sexual. A participação do parceiro deve ser incentivada, tornando fundamental que as equipes de saúde realizem esse acompanhamento. Para a melhoria dos índices de sífilis gestacional, sugere-se a implementação de estratégias que efetivem o acompanhamento dos casos, aperfeiçoem a qualidade do atendimento e facilitem o acesso das mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, garantindo diagnóstico precoce e manutenção do acompanhamento durante toda a gestação.

REFERÊNCIAS

- ABREU, G. R. de *et al.* Adequação da assistência pré-natal ofertada à mulher indígena: características maternas e dos serviços de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 4, p. 62-69, out./dez. 2018.
- ARGENTON, Isabel Schuster *et al.* A análise de trajetórias assistenciais como metodologia de integração ensino-serviço na saúde. **Revista Brasileira de Educação Médica**, São Paulo, v. 42, n. 4, p. 62-69, out./dez. 2018.
- BRANDES, Marcela. Precarização na saúde de Porto Alegre: 95% da Atenção Básica é terceirizada. *In*: BRASIL de Fato. Porto Alegre, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/02/07/precarizacao-na-saude-de-porto-alegre-95-da-atencao-basica-e-terceirizada/>. Acesso em: 22 fev. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis**: manual de bolso. Brasília: MS, 2007a. *E-book*. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_prevencao_transmissao_verticalhivsisifilis_manualbolso.pdf. Acesso em: 20 fev. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Sistemas de Informações de Agravos de Notificações – Sinan**: normas e rotinas. 2. ed. 2007b. *E-book*. Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Portarias/Manual_Normas_e_Rotinas.pdf. Acesso em: 10 fev. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013**. Institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1412_10_07_2013.html. Acesso em: 20 fev. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Informativa nº 2-SEI/2017 - DIAHV/SVS/MS**. Altera os critérios de definição de casos para notificação de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita. Brasília: MS, 2017. *E-book*. Disponível em: https://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Sifilis-Ges/Nota_Informativa_Sifilis.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 580, de 22 de março de 2018**. Regulamenta o disposto no item XIII.4 da Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece que as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS) serão contempladas em Resolução específica, e dá outras providências. Brasília, DF: CNS, 2018a. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2018/resolucao-no-580.pdf/view>. Acesso em: 22 jan. 2026.
- BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018b.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 11 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis**. 1. ed. Brasília: MS, 2021. *E-book*. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_sifilis_1ed.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. *E-book*. Brasília: MS, 2022a. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022b. *E-book*. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_hiv_sifilis_hepatites.pdf. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução nº 674, de 6 de maio de 2022**. Dispõe sobre a tipificação da pesquisa e a tramitação dos protocolos de pesquisa no Sistema CEP/Conep. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022c. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2022/resolucao-no-674.pdf/view>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico: Sífilis 2023**. Brasília: MS, 2023. *E-book*. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out.2023>. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico: Sífilis 2025**. Brasília: MS, 2025. *E-book*. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-da-sifilis.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2026.

CESAR, Juraci Almeida *et al.* Características sociodemográficas e de assistência à gestação e ao parto no extremo sul do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 5, p. 985-994, 2011.

CESAR, Juraci Almeida *et al.* Não realização de teste sorológico para sífilis durante o pré-natal: prevalência e fatores associados. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 23, e200012, 2020.

CUSCHIERI, S. As diretrizes do STROBE. **Saudi Journal of Anaesthesia**, [s. l.], v. 13, supl. 1, p. S31-S34, abr. 2019.

DOMINGUES, R. M. S. M.; SZKLO, A. J. D. B. Sífilis materna e congênita: ainda um desafio. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 6, p. 1109-1111, jun. 2013.

EKSÉLIUS, L.; GERDIN, B.; VAHLQUIST, A. The syphilis pandemic prior to penicillin: origin, health issues, cultural representation and ethical challenges. **Acta Dermato-Venereologica**, [s. l.], v. 104, adv34879, 4 mar. 2024.

GERHARDT, T. E. *et al.* **Itinerários terapêuticos**: integralidade no cuidado, avaliação e formação em saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2016. *E-book*. Disponível em: <https://www.cepesc.org.br/wp-content/uploads/2017/07/livro-itinerarios-terapeuticos-1.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2026.

HULLEY, S. B. *et al.* **Delineando a pesquisa clínica**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

KESSLER, A. L.; RUIZ, E. N. F.; SCHUCH, I. As trajetórias assistenciais de usuários com obesidade na rede de atenção à saúde de Porto Alegre. **Demetra: Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 135-148, jan./jun. 2023.

LUZ, L. A.; AQUINO, E. M.; MEDINA, M. G. Avaliação da qualidade da atenção pré-natal no Brasil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, p. 111-126, 2018.

MACÊDO, V. C. *et al.* Sífilis na gestação: barreiras na assistência pré-natal para o controle da transmissão vertical. **Cadernos de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 417-423, 2020.

MARQUES, B. L. *et al.* Orientações às gestantes no pré-natal: a importância do cuidado compartilhado na atenção primária em saúde. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. e20200098, 2021.

PAULA, M. A. *et al.* Diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes nos serviços de Atenção Básica. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 8, p. 3331–3340, 2022.

PORTO ALEGRE. **Capital é referência na implantação do prontuário eletrônico**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2016. Disponível em: https://www2.portoalegre.rs.gov.br/acessibilidade_smarty/default.php?p_secao=3&projeto_sec=144&pg=1895&p_reg=190274. Acesso em: 25 fev. 2026.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório de gestão**: Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 2º quadrimestre de 2022. Porto Alegre: Prefeitura de Porto Alegre, 2022.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. **Boletim epidemiológico: sífilis**. Porto Alegre: Prefeitura de Porto Alegre, 2025. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/vigilancia-em-saude/Boletim%20S%C3%ADfilis_0.pdf. Acesso em: 14 fev. 2026.

ROCHA, A. F. B. *et al.* Complications, clinical manifestations of congenital syphilis, and aspects related to its prevention: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, n. 4, e20190318, 2021.

SCHLUETER, A. *et al.* Adverse pregnancy outcomes associated with maternal syphilis infection. **The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine**, [s. l.], v. 35, n. 25, p. 5828-5833, 12 dez. 2022.

SILVA, F. S. **Mulheres negras e brancas: análise do acesso às consultas de pré-natal no Estado do Rio Grande do Sul**, 2016. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

SILVA, E. S. *et al.* Avaliação do pré-natal na atenção primária no Nordeste do Brasil: fatores associados à sua adequação. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 53, p. 43, 2019.

SILVA, H. B. M. *et al.* Syphilis in pregnancy and adverse birth outcomes: A nationwide longitudinal study in Brazil. **Int J Gynaecol Obstet.**, [s. l.], v. 166, n. 1, p. 80-89, jul. 2024.

SOARES, M. A. S.; AQUINO, R. Associação entre as taxas de incidência de sífilis gestacional e sífilis congênita e a cobertura de pré-natal no Estado da Bahia, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 3, e00209520, 2022.

TORRES, P. M. A. *et al.* Factors associated with inadequate treatment of syphilis during pregnancy: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [s. l.], v. 75, n. 6, p. e20210965, 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). **TeleCondutas: Sífilis**. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2023. *E-book*. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessaunders/documentos/telecondutas/tc_sifilis.pdf. Acesso em: 12 fev. 2026.

WARREN, H. P. *et al.* State requirements for prenatal syphilis screening in the United States, 2016. **Maternal and Child Health Journal**, [s. l.], v. 22, n. 9, p. 1227-1232, set. 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Sexually transmitted infections: implementing the Global STI Strategy**. Geneva: WHO, 2017. *E-book*. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258740/WHO-RHR-17.18-eng.pdf?sequence=1.2>. Acesso em: 22 fev. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Relatório sobre HIV, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis**. Genebra, WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240027077>. Acesso em: 25 fev. 2026.

APÊNDICE A - COLETA DE DADOS DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO

Perfil Sociodemográfico
1. Escolaridade no cadastro:
1- 0 anos de estudo – Analfabeto
2- 1 a 4 anos de estudo – Ensino Fundamental Incompleto
3- 5 a 8 anos de estudo – Ensino Fundamental Completo
4- 9 a 11 anos de estudo – Ensino Médio Incompleto
5- 12 anos de estudo – Ensino Médio Completo
6- 13 a 15 anos de estudo – Ensino Superior Incompleto
7- Mais de 16 anos de estudo - Superior Completo
9 -Ignorado
2. Raça/cor:
1- Branca
2- Preta/Parda
3- Amarela
4-Indígena
3. Idade:
descritiva: _____ (colocar exato)
4. Idade gestacional primeira consulta:
descritiva: _____ (colocar exato)
5. Idade gestacional diagnóstico:
descritiva: _____ (colocar exato)
6. Idade gestacional por trimestre no momento do diagnóstico:
1- 1º trimestre: (0- 12 semanas gestacionais)
2- 2º trimestre: (12-28 semanas gestacionais)
3- 3º trimestre (28+ semanas)
7. Bairro da unidade de saúde:
descritiva: _____ (colocar exato)
8. Distrito sanitário da unidade de saúde:

descritiva: _____ (colocar exato)
9. Vulnerabilidades:
Descritiva: _____ (colocar exato)
10. Ocupação:
1- Não
0- Sim
Se ignorado, deixar em branco
11. Se possui ocupação, qual?
descritiva: _____ (colocar exato)
12. Foi questionado se possui parceria sexual?
0- Sim
1- Não
13. Se questionado, possui parceria sexual?
0- Sim
1- Não
Se ignorado, deixar em branco

Fonte: elaborado pela autora.

**APÊNDICE B - COLETA DE DADOS REFERENTES À IDENTIFICAÇÃO,
DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS TRAJETÓRIAS ASSISTENCIAIS**

Dados do Agravo
1. Realização do primeiro exame treponêmico/Testagem rápida de sífilis no pré-natal:
1- Sim, até as 12 semanas
2- Não, após as 12 semanas
3- Sífilis prévia anterior ao pré-natal (tratada anterior ao pré-natal)
9- Ignorado
2. Titulação do primeiro exame de VDRL realizado:
descritiva: _____ (colocar exato)
3. Classificação Clínica da Sífilis:
1- Primária
2- Secundária
3- Terciária
4- Latente
4. Primeiro tratamento da gestante prescrito e realizada de forma completa:
0- Realizado
1- Não realizado
5. Tratamento prescrito:
1- benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, dose única
2- benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, 1x por semana, por três semanas.
3- Outro esquema
4- Não foi prescrito
9- Ignorado
6. Tratamento da gestante realizado até 30 dias antes do parto:
0- Sim
1- Não
Se ignorado, deixar em branco
7. Exames VDRL após tratamento, suficientes para controle e acompanhamento:
0- Sim

1- Não
Se ignorado, deixar em branco
8. Apresentou queda ou aumento do VDRL (Não treponêmico):
1- Somente queda;
2- Teve pelo menos 1 episódio de aumento após tratamento;
3- Titulação se manteve igual;
4- Sem registro de outras titulações;
9- Ignorado.
9. Necessidade de retratamento, sendo este realizado ou não:
0- Não
1- Sim
Se ignorado, deixar em branco
10. Eventos adversos durante a gestação e parto:
0- Não
1- Sim
Se ignorado, deixar em branco
11. Se evento adverso, qual?
descritiva: _____ (colocar exato)

Fonte: elaborado pela autora.

APÊNDICE C - COLETA DE DADOS EM RELAÇÃO À PARCERIA SEXUAL

Dados parceria sexual
1. Foi realizada a testagem da parceria sexual?
0 - sim
1 - não
2. Se realizada a testagem parceiro, qual o resultado:
1- Teste reagente
0- Teste não reagente
3. Tratamento prescrito a parceria:
1- Prescrito e realizado
2- Prescrito e Não realizado
3- Não foi prescrito tratamento
4- Sem parceiro
9- Ignorado
4. Parceria tratada concomitante com a gestante:
1- Sim
2- Não
3- Não tratou
4- Sem parceria
9 - ignorado

Fonte: elaborado pela autora.

APÊNDICE D - PARECER CONSUBSTANCIADO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: TRAJETÓRIA ASSISTENCIAL DE MULHERES COM SÍFILIS GESTACIONAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM SÍFILIS CONGÊNITA: COORTE RETROSPECTIVA

Pesquisador: Deise Lisboa Riquinho

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 88626325.0.0000.5347

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.624.111

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento **Informações Básicas da Pesquisa**, "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2557969.pdf", datada de 13/05/2025, Versão 1.

Trata-se do parecer da primeira versão do Projeto de Pesquisa: Trajetória Assistencial de Mulheres com Sífilis Gestacional e sua Associação com Sífilis Congênita: uma coorte retrospectiva, tendo como responsável Deise Lisboa Riquinho. Integram a equipe de pesquisa SABrina Terezinha de Souza Gilli Brundo, Stela Maris de Jesus Castro, Pedro Paiva Cyntrao, Gisele Cristina Tertuliano, Tatiana Heidi Oliveira, Vilma Constancia Fioravante dos Santos, Franciela Delazeri Carlotto, Amiry Monteiro Sanca, DEISE TAURINO RAMOS, Letícia Becker Vieira, Adriana Roese Ramos, Carolina Nicolodi Dias, Janilce Domeles de Quadros. O parecer foi elaborado com base nos documentos do protocolo de pesquisa.

Introdução:

Este projeto de pesquisa advém de um estudo com foco na sífilis congênita em que se partiu das notificações para estudar as características sociodemográficas, de território e de desfechos desfavoráveis. Observou-se maior ocorrência entre pessoas pretas e com menor escolaridade,

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.624.111

de territórios mais periféricos e populosos. Desfechos desfavoráveis, como aborto e morte, foram mais frequentes entre aquelas sem pré-natal. Informações incompletas ou ignoradas impediram explorar e analisá-las em diferentes perspectivas. Por isso, buscar-se-á explorar os registros profissionais para reconstruir o acesso, diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional, de forma explicar sua ocorrência e apontar formas de enfrentamento, como a educação profissional, por exemplo. Nesse sentido, as Trajetórias Assistenciais consistem nos movimentos que indivíduos ou grupos percorrem visando preservação, tratamento e recuperação da saúde, considerando o contexto em que se introduzem e o uso de todos os recursos que encontram disponíveis. A sua análise permite reconhecer caminhos traçados pelos usuários nos serviços de saúde permitindo, assim, identificar os cuidados realizados e investigar a resolatividade da rede de atenção em saúde que estão inseridos (Gerhardt, 2016; Argenton, 2018). A compreensão das Trajetórias Assistenciais reforça não apenas as experiências individuais dos usuários na busca do cuidado, mas o encontro produzido na assistência por usuários e profissionais da rede de saúde. Isso implica que os modelos de atenção, muitas vezes idealizados em sua base teórica, ganham forma na prática diária, por meio das ações de diferentes atores. Cada um desses contribui com seu repertório de saberes e vivências, resultando em um conjunto diversificado de práticas, que dão origem a novos roteiros e formas de cuidado, adaptadas às realidades específicas de cada um desses usuários (Gerhardt, 2016; Argenton, 2018; Kessler, 2023). Nesse contexto, compreender as Trajetórias Assistenciais torna-se ainda mais relevante quando se consideram situações específicas de vulnerabilidade, como no caso da sífilis gestacional. A infecção adquirida durante qualquer estágio da gestação, pode ser transmitida verticalmente, da mãe para o feto, representando um sério risco à saúde materno-fetal, podendo ocasionar desfechos negativos. Entre as complicações associadas à sífilis congênita, destacam-se o aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer, malformações fetais e infecções neonatais, que podem ser assintomáticas ou apresentar manifestações clínicas graves (Rocha, 2021). Em relação à saúde materna, a infecção não tratada pode evoluir para formas mais severas, comprometendo o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, além de que, a presença da sífilis aumenta a suscetibilidade a outras infecções sexualmente transmissíveis. Diante desses riscos, é fundamental garantir o acompanhamento adequado das gestantes e de suas parcerias sexuais, priorizando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz da infecção (Brasil, 2022b; Schlueter et al., 2022). Em relação aos dados Nacionais, mesmo com todos os avanços na detecção da sífilis, os números da sífilis gestacional e congênita seguem aumentando.

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.624.111

Conforme Boletim Epidemiológico de Sífilis (2023), no ano de 2022 foram notificados 83.034 casos de sífilis gestacional em todo o Brasil, com uma taxa de detecção de 32,4 casos por 1.000 Nascidos Vivos (NV), representando um aumento de 15,5% se comparado ao ano anterior. As taxas de detecção das regiões Sudeste (39,2 casos por 1.000 NV) e Sul (33,8 casos por 1.000 NV) foram superiores à nacional (Brasil, 2023). Conforme o SINAN e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), entre 2018 e 2024, na Macrorregião de Saúde Metropolitana, especificamente na 10a Região de Saúde, foram notificados 10.119 casos de sífilis gestacional, correspondendo a uma taxa de 59,03 casos por 1.000 nascidos vivos. Desses, 6.001 ocorreram em Porto Alegre, 1.382 em Alvorada, 1.218 em Gravataí e 1.074 em Viamão, sendo os municípios com as maiores taxas da região (Rio Grande do Sul, 2025). A partir de 2018, as taxas de incidência da doença ultrapassaram a marca de 39%, atingindo 39,81% neste ano. O pico foi registrado em 2021 e 2022, com taxas de 75,4% e 70,26%, respectivamente. Em 2024, observou-se uma redução para 49,68%. No entanto, os índices permaneceram elevados em comparação com o período anterior a 2018 (Rio Grande do Sul, 2025). No Boletim Epidemiológico da Sífilis de 2023, elaborado pelo Ministério da Saúde, no município de Porto Alegre/RS, observou-se um decréscimo na taxa de detecção dos casos de sífilis gestacional em comparação aos dois anos anteriores. Dentre todos os casos de sífilis, 25,6% correspondem à sífilis na gestação, sendo a maioria 54,9% dos casos em pessoas de raça branca, e 26,9% em pessoas de raça preta (Brasil, 2023). Enquanto o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS e Sífilis do Estado do Rio Grande do Sul do ano de 2022 (2023) evidenciou que, no período de 2011 a 2022, a taxa de casos passou de 4,6 por 1.000 nascidos vivos em 2011 para 38,1 por 1.000 nascidos vivos em 2021 (Rio Grande do Sul, 2023). Além disso, nesse mesmo período, 53,5% dos casos ocorreram na Macrorregião Metropolitana, sendo 29,0% na 10a Região de Saúde. Além disso, no ano de 2021, vinte e oito municípios apresentaram valor superior à taxa estadual (38,1/1.000 nascidos vivos), sendo as mais elevadas na Macrorregião Metropolitana em Alvorada (78,3/1.000 nascidos vivos) e Viamão (75,4/1.000 nascidos vivos) (Rio Grande do Sul, 2025). A alta prevalência do agravo no país também está ligada ao contexto social das gestantes. O Brasil, um dos mais desiguais do mundo, com baixos níveis de educação e com uma visão estigmatizada e conservadora sobre saúde sexual e reprodutiva. Portanto, a promoção de estratégias de educação em saúde à população e permanente aos profissionais, ajudará a minimizar barreiras e promover menor transmissão da sífilis (Magalhães et al., 2013; Soares, 2022). Estudos realizados no Rio Grande do Sul, revelaram que mulheres negras, em geral, realizaram menos consultas pré-natais e

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.624.111

iniciam o acompanhamento tardiamente. Além disso, essas mulheres tendem a residir em locais mais distantes dos serviços de saúde, geralmente enfrentam barreiras socioeconômicas, como a falta de recursos para transporte e a perda de horas de trabalho, além de fatores educacionais e culturais que dificultam o acesso a um pré-natal de melhor qualidade, incluindo a testagem sorológica para sífilis (Silva, 2018; César, 2020). Além deste, outros estudos nacionais reforçam que, especificamente na realização da consulta pré-natal, gestantes adolescentes e negras recebem atendimento assistencial de menor qualidade em relação às mulheres brancas, evidenciando a persistência do racismo institucional nos serviços de saúde e no acesso ao cuidado gestacional (César, 2011; Luz, 2018). Em concordância a isso, a cobertura das consultas pré-natais de mulheres indígenas são inferiores a de mulheres não indígenas, com ênfase na região do Norte e Nordeste. Além destes, são identificados como as principais fragilidades de acesso à infraestrutura precária dos serviços, tempo de consulta escassos, exames complementares insuficientes, número de consultas inadequadas e pouca captação precoce das gestantes (Luz, 2018; Silva, 2019). Estudo realizado nos Estados Unidos no ano de 2021 destacou que a literatura sobre os Determinantes Sociais de Saúde aponta que pessoas em situação de vulnerabilidade social e privação econômica têm menor probabilidade de acessar os cuidados de saúde necessários. Nesse contexto, oferecer suporte adicional a gestantes socialmente vulneráveis e em situação de risco é essencial para reduzir os casos de sífilis congênita associados à vulnerabilidade materna e ao contexto social (Chan, 2021). Mesmo entre as mulheres que realizam e possuem acesso ao pré-natal, há inúmeras oportunidades perdidas no diagnóstico e tratamento da sífilis. A remoção de barreiras para a realização de um pré-natal adequado envolve diversos fatores, incluindo a captação precoce da gestante, o aconselhamento pré-natal, educação em saúde, a solicitação e realização de exames conforme os protocolos, a obtenção dos resultados em tempo oportuno e o tratamento da sífilis realizado adequadamente pela gestante, e se possível e necessário, de seu parceiro (Macêdo, 2020; Cerqueira, 2021). Diante do exposto acima, estudos Nacionais e Internacionais, reforçam a importância da captação precoce da gestação, rastreamento da sífilis em mais de um momento durante as consultas de pré-natal, sendo a primeira testagem na primeira consulta, priorizar a testagem em gestantes de menor nível socioeconômico, mulheres da cor da pele preta e as que pouco aderem às consultas de pré-natal (Warren, 2018; Silva, 2019; Cesar, 2020). A criação de programas pré-natais adequados, que se adequem ao contexto social das gestantes, e o gerenciamento de casos para pessoas com sífilis podem ajudar a reduzir barreiras ao atendimento médico decorrentes de diferenças sociais, culturais e

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.624.111

linguísticas, além de incentivar maior adesão e continuidade no cuidado (Silva, 2019; Abreu, 2024). A partir desta contextualização, apresenta-se como questão de pesquisa: como se configuram as trajetórias assistenciais de pessoas com sífilis gestacional durante o pré-natal na rede pública de Porto Alegre e região metropolitana, no período de 2018 a 2024, e quais são os fatores relacionados à sífilis congênita no recém-nascido?

Metodologia Proposta:

Estudo de coorte retrospectiva (Hulley, 2015) da análise da Trajetória Assistencial da sífilis gestacional de pessoas que realizaram o acompanhamento pré-natal na APS, com base na verificação de dados secundários disponíveis no prontuário eletrônico, entre os anos de 2018 e 2024, nos municípios de Alvorada, Gravataí, Porto Alegre e Viamão, no estado do Rio Grande do Sul."

Critério de Inclusão e exclusão: dentre os critérios de elegibilidade no estudo, serão incluídas as gestantes, que: foram notificadas para sífilis gestacional, pelas unidade de saúde da APS, durante o período estipulado da pesquisa; realizaram o acompanhamento pré-natal exclusivamente nas unidades de atenção primária vinculadas às prefeituras municipais no período selecionado; tiveram o diagnóstico de sífilis durante a gestação, podendo ser um novo caso ou uma reinfecção, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde; E, os critérios de exclusão, serão excluídas as mulheres que: em que o pré-natal não foi realizado exclusivamente pelos serviços da atenção primária, mas de forma concomitante com os serviços de saúde secundários e terciários, incluindo as que fizeram pré-natal de alto risco; não foram acompanhadas pelo serviço público de saúde, que realizaram pelo particular, ou as que o acompanhamento foi feito pelas unidades conveniadas à prefeitura (sendo do Grupo Hospitalar Conceição e Hospital de Clínicas de Porto Alegre); não realizaram o acompanhamento pré-natal ou que não possuem registro em prontuário do acompanhamento; não residiam em Alvorada, Gravataí, Porto Alegre ou Viamão (RS); aquelas que apresentaram testes falso-positivos para sífilis e os casos de cicatriz sorológica, sendo, mulheres sem o exame ou com resultado negativo dos exames treponêmicos e não treponêmicos (ambos devem ser reagentes). Serão incluídas todas as notificações de sífilis congênita no período de 2018 até 2024 nos municípios do estudo e excluídas aquelas cujas mães não foram notificadas com sífilis gestacional.

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.624.111

Metodologia de Análise de Dados: "os dados de interesse serão digitados e armazenados em uma planilha do programa Excel®, validados, e posteriormente transportados para software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows versão 21.0, para as análises estatísticas. As variáveis quantitativas serão descritas por média e desvio padrão ou mediana e amplitude interquartilica e as variáveis categóricas serão descritas por frequências absolutas e relativas. Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas, os testes qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher serão utilizados. Em caso de variáveis politômicas, a análise dos resíduos ajustados será utilizada para localizar as associações significativas. Para comparar médias, o teste t -student será aplicado. Em caso de assimetria, o teste de Mann-Whitney será aplicado. O critério para a entrada da variável no modelo multivariado será de que a mesma apresente um valor $p < 0,20$ na análise bivariada e o de permanência no modelo final será de que a variável apresenta um valor $p < 0,10$. O nível de significância adotado será de 5% ($p < 0,05$). Para garantir a confiabilidade do estudo, o checklist Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) para estudos observacionais será utilizado.

Tamanho da Amostra no 9.094.

Cronograma de Execução - Coleta de Dados: 03/11/2025 a 31/12/2026.

Orçamento: R\$45.850,00 (A presente proposta de pesquisa será submetida à CHAMADA PPSUS - PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: gestão compartilhada em saúde/ FAPERGS No 01/2025).

Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc)? Sim

Detalhamento:

A coleta de dados será realizada com base nas informações registradas pelos profissionais de saúde nos prontuários dos participantes, por meio do sistema e-SUS, visando investigar aspectos do acompanhamento e tratamento da sífilis gestacional. Os prontuários serão selecionados, analisados individualmente e os dados extraídos serão organizados em uma planilha do Microsoft Excel para posterior análise. Para a coleta de dados, cada prontuário será aberto apenas durante o período correspondente ao pré-natal relacionado ao caso de sífilis gestacional. Em seguida, as informações referentes ao perfil da usuária serão extraídas e imediatamente transferidas para a planilha de coleta, garantindo a organização e a segurança dos dados (anonimato). Para a coleta e análise dos dados, será utilizado o manual

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.624.111

TeleCondutas: Sífilis, elaborado pela TelessaúdeRS-UFRGS em 2023. Este manual contém dados e condutas atualizadas, sendo um consenso entre o manual da Prefeitura de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul e o do Ministério da Saúde. Além disso, oferece informações de fácil acesso, contribuindo para a implementação de condutas adequadas no diagnóstico e manejo da sífilis. E neste material, os termos "adequado" e "inadequado" são utilizados para classificar o acompanhamento e tratamento com base na prescrição, no tempo de tratamento, na conclusão deste, entre outros fatores. Assim, esses mesmos termos serão adotados neste projeto. Para avaliação do perfil sociodemográfico da sífilis gestacional - questionário 1- (Apêndice 1) nos municípios estabelecidos pela pesquisa, durante o período selecionado, serão consideradas informações maternas, sendo as variáveis: Escolaridade; Raça/Cor/etnia; Nacionalidade; Idade; Idade gestacional na primeira consulta de pré-natal; Idade gestacional por trimestre no momento do diagnóstico; Distrito de residência; Se possui parceria sexual; Existência ou não de uma ocupação. Para a identificação, descrição e avaliação das Trajetórias Assistenciais -questionário 2- (Apêndice 2) de pessoas gestantes com sífilis, serão considerados aspectos relacionados ao agravo, como os fatores associados, às condutas adotadas, os tratamentos realizados, a adesão tanto da gestante quanto da parceria, entre outros. Com base nessas informações, as trajetórias serão classificadas como Adequadas ou Inadequadas para o manejo da sífilis gestacional. Sendo assim, os seguintes itens serão analisados: Idade gestacional do diagnóstico de sífilis; Testagem IST's na primeira consulta de pré-natal; Tratamento da gestante completo; Tratamento prescrito; Tratamento da gestante realizado até 30 dias antes do parto; Exames VDRL mensais após tratamento; Se teve aumento ou diminuição da titulação do VDRL; Necessidade de retratamento. Além desses, também serão avaliados, quando aplicável, o exame, tratamento e adesão da parceria da gestante -questionário 3- (Apêndice 3), sendo analisados: realizada testagem; tratamento prescrito; parceiro tratado concomitante com a gestante. E, para a classificação das Trajetórias Assistenciais, serão utilizados os critérios do Ministério da Saúde para a definição de casos de sífilis gestacional (Brasil, 2017). Será considerada uma Trajetória Assistencial Adequada quando a gestante: a) realiza testagem para sífilis na primeira consulta de pré-natal até as 12 semanas gestacionais; b) faz completamente o tratamento prescrito com benzilpenicilina benzatina iniciado até 30 dias antes do parto, ou, se necessidade de tratamento, o cumpre no mesmo prazo; c) executa exames de VDRL (não treponêmico) mensalmente após o término do tratamento até o parto; d) se possui parceria sexual, faz a testagem e realiza o tratamento completo concomitantemente à gestante, se necessário. Já uma Trajetória Assistencial

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.624.111

Inadequada refere-se às gestantes que, não receberam as orientações e condutas do pré-natal conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, ou que não aderiram às recomendações e tiveram abandono de tratamento.

Centros Centro Coparticipante: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre

Propõe dispensa do TCLE? Sim

Justificativa: conforme a Resolução CNS no 466, de 12 de dezembro de 2012, item IV.8, "nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento". Em conformidade também com a Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), este estudo seguirá todos os princípios dispostos no Art. 6º, assegurando a utilização dos dados exclusivamente para fins de pesquisa científica. Os dados de identificação dos usuários serão codificados para fins de anonimização, e informações sensíveis, como telefone, CPF e endereço residencial, não serão utilizadas. Considerando que a pesquisa envolve a análise retrospectiva de um número expansivo de prontuários, e que o contato direto com os participantes para obtenção do consentimento seria logisticamente inviável e comprometeria a viabilidade do estudo, solicitamos a dispensa da assinatura do TCLE, conforme previsto nas normativas éticas e legais vigentes. Apresenta-se o Termo de Compromisso de Uso de Dados (TCUD) (Apêndice 5). O acesso inicial aos prontuários ocorrerá mediante identificação dos pacientes apenas para localização dos registros, e que, após a coleta das informações necessárias, todos os dados serão devidamente codificados e anonimizados em planilha específica, e os dados de identificação serão excluídos, de forma a garantir a privacidade e a confidencialidade dos participantes. Ressalta-se, ainda, que apenas os pesquisadores devidamente autorizados terão acesso aos dados, que serão armazenados de forma segura, respeitando as normas éticas vigentes.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Analisar a trajetória assistencial de pessoas que realizaram o acompanhamento pré-natal na rede pública, notificadas para sífilis, entre 2018 e 2024 e os fatores relacionados à sífilis

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 91.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.624.111

congênita no recém-nascido em uma capital e região metropolitana do sul do Brasil.

Objetivo Secundário:

Descrever o perfil sociodemográfico da sífilis gestacional e congênita no campo de estudo e período selecionado; Caracterizar os fatores associados à sífilis gestacional e congênita dos municípios selecionados no período correspondente; Analisar a distribuição espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita nos municípios selecionados no período correspondente e avaliar a tendência temporal.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: a pesquisa prevê riscos mínimos à população, como a quebra de confidencialidade.

Benefícios: os benefícios do estudo estão relacionados à ampliação da compreensão das trajetórias assistenciais das pessoas com sífilis gestacional nos municípios em estudo e seus fatores de risco, auxiliando no desenvolvimento e manutenção de políticas públicas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Documentos: Termos de anuência institucional das prefeituras de Viamão, Alvorada e Gravataí; Termo de Compromisso de Uso de Dados, todos preenchidos e assinados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não foram observados óbices éticos nos documentos do estudo.

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 510, de 2016, na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação do protocolo de pesquisa proposto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P	13/05/2025		Aceito

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
 Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE
 Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.624.111

Básicas do Projeto	OJETO_2557969.pdf	13:50:33		Aceito
Outros	FORMULARIO_PROJETO_DE_PESQUISA_PMPAassinado.pdf	13/05/2025 13:40:46	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	Termo_Porto_alegre.pdf	13/05/2025 13:38:32	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	termo_Viamao.pdf	13/05/2025 13:37:40	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	Termo_Gravatai.pdf	13/05/2025 13:37:26	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	termo_Alvorada.pdf	13/05/2025 13:37:17	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_detalhado.pdf	13/05/2025 13:30:05	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCUD.pdf	13/05/2025 13:28:26	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_rosto_Assinada.pdf	13/05/2025 13:26:14	Deise Lisboa Riquinho	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 06 de Junho de 2025

Assinado por:
MARCIA HOLSBACH BELTRAME
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

 Prefeitura de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSA	
--	--	---

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituição Coparticipante

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: INCIDÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À SÍFILIS CONGÊNITA EM PORTO ALEGRE: UM ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVA

Pesquisador: Deise Lisboa Riquinho

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 76974424.0.3001.5338

Instituição Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.757.499

Apresentação do Projeto:

TRATA-SE DE RETORNO DE PENDÊNCIAS - PARECER CONSUBSTANCIADO 6.710.261 DE 19/03/2024.

A sífilis congênita se destaca no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, por sua vez, é a capital com maior incidência, com 34,8 casos/1000 nascidos vivos. Assim, o objetivo do estudo é analisar quais são os fatores associados à sífilis congênita em Porto Alegre, assim como identificar os bairros com maiores índices. Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, com dados secundários disponíveis nas fichas de notificação de sífilis congênita e sífilis em gestante, de janeiro de 2012 a dezembro de 2022, e análise de prontuários. Após aprovação no Comitê de Ética, os dados serão solicitados à Secretaria de Saúde de Porto Alegre. A população do estudo serão as gestantes com sífilis. Os dados de interesse serão digitados e armazenados em planilhas, validados e, posteriormente, transportados para software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para as análises estatísticas. Para o georreferenciamento, será utilizado o sistema ArcGIS 10®. Espera-se que essa proposta de projeto de pesquisa possibilite maior sensibilização dos profissionais da saúde, principalmente na Atenção Primária, assim como dos gestores municipais e estaduais, sobre a temática da sífilis e seus desfechos.

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro: Centro Histórico		CEP: 90.010-040	
UF: RS	Município: PORTO ALEGRE		
Telefone: (51)3289-5517	Fax: (51)3289-2453	E-mail: cep_sms@hotmail.com	

 Prefeitura de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSPA	
---	--	---

Continuação do Parecer: 6.757.499

Objetivo da Pesquisa:

Principal:

Estimar a incidência de sífilis congênita em Porto Alegre, abrangendo o período de janeiro de 2012 até dezembro de 2022, e analisar os fatores correlacionados, com a subsequente identificação dos bairros que apresentam as taxas mais elevadas desse agravo à saúde.

Secundários:

- ¿ Caracterizar a população em estudo conforme as características sociodemográficas e clínicas;
- ¿ Identificar os desfechos perinatais associados aos casos de sífilis congênita;
- ¿ Identificar os fatores sociodemográficos maternos relacionados à incidência de sífilis congênita;
- ¿ Construir o georreferenciamento dos casos de sífilis congênita conforme o bairro de residência materna.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Os riscos e benefícios informados pelos pesquisadores no documento de informações básicas do projeto são:

Riscos

A pesquisa prevê riscos mínimos à população, como a quebra de confidencialidade. Para evitar a possível identificação das pessoas, os nomes das mulheres e dos recém nascidos serão codificados. Portanto, a identidade das pacientes será mantida em sigilo em todos os materiais resultantes da pesquisa, garantindo a privacidade e o anonimato.

Benefícios

Os benefícios do estudo estão relacionados à ampliação da compreensão sobre a sífilis congênita em Porto Alegre nos últimos dez anos, assim como seus fatores de risco, auxiliando no desenvolvimento e manutenção de políticas públicas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

- a. Título: Incidência e fatores associados à sífilis congênita em Porto Alegre: um estudo de coorte retrospectiva.
- b. Pesquisador responsável: Enfermeira Dra. Deise Lisboa Riquinho.
- c. Equipe de pesquisa: Franciela Delazeri Carlotto.
- d. Nível da pesquisa: Projeto de Mestrado.
- e. Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- f. Curso: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro: Centro Histórico	CEP: 90.010-040		
UF: RS	Município: PORTO ALEGRE		
Telefone: (51)3289-5517	Fax: (51)3289-2453	E-mail: cep_sms@hotmail.com	

 Prefeitura de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSPA	
--	--	---

Continuação do Parecer: 6.757.499

do Sul.

g. Local de realização do estudo: Ambiente da Escola de Enfermagem da UFRGS, com a coleta de dados a partir das fichas de notificação de sífilis em gestante e sífilis congênita, disponíveis no banco do SINAN já estruturado pelo serviço de vigilância de Porto Alegre.

h. Duração do estudo: A pesquisa terá duração de aproximadamente 27 meses, com previsão de início no primeiro trimestre de 2023 e término no primeiro trimestre de 2025.

i. Número de sujeitos da pesquisa: Não haverá abordagem de indivíduos.

j. Critérios de inclusão: Serão incluídas as gestantes com diagnóstico de sífilis na gestação, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde (Brasil, 2022b), e seus respectivos bebês, independente do desfecho perinatal, com nascimento hospitalar.

k. Critérios de exclusão: As perdas da amostra serão as gestantes que apresentarem testes falso-positivos para sífilis, as que não residam em Porto Alegre e os binômios sem registro das variáveis avaliadas, que posteriormente serão quantificadas.

l. Data prevista para conclusão do estudo: Primeiro trimestre de 2025.

m. Orçamento: O orçamento apresentado se apresenta no valor de R\$ 2.708,90 (dois mil, setecentos e oito reais com noventa centavos). Os valores serão de responsabilidade da pesquisadora principal.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

a. Analisar a redação do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Solicitada a dispensa do mesmo. Justificativa: Estudo será realizado a partir de dados secundários coletados em banco previamente construído pela vigilância e a partir de dados registrados em prontuários da atenção primária (e -SUS), secundária (Gercon) e terciária (Gerint), tanto do recém-nascido quanto da respectiva mãe, conforme instrumentos, não sendo necessário uso de TCLE. Deferida por se tratar de uso de informações de banco de dados.

b. Termo de uso de imagem e som - Dispensado.

c. Formulário de projeto de pesquisa (quem assinou e quando foi assinado): Ausente a assinatura da responsável. Identificada assinatura do Vice Pró-Reitor de Pesquisa, Jefferson Cardia Simões, em 27 de novembro de 2023.

d. Termo de ciência e autorização da coordenação (quem assinou e quando foi assinado): Assinado por Sílvia Adriana Mayer Lentz, matrícula 427989/04, Coordenadora da Assessoria de Ensino e Pesquisa, em 19 de dezembro de 2023 e, posteriormente por Vânia Maria Frantz, matrícula 484766/01, Diretora da Diretoria de Atenção Primária em Saúde, em 19 de janeiro de 2024; ambas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro: Centro Histórico	CEP: 90.010-040		
UF: RS	Município: PORTO ALEGRE		
Telefone: (51)3289-5517	Fax: (51)3289-2453	E-mail: cep_sms@hotmail.com	

 Prefeitura de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSPA	 Plataforma Brasil
--	---	--

Continuação do Parecer: 6.757.499

- e. Termo de compromisso de utilização e divulgação dos dados - Não localizado.
- f. Outros documentos - Parecer consubstanciado, N° 6.636.396, do CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, datado de 05 de fevereiro de 2024.
- g. Emenda - Nada consta.

Recomendações:

Foi juntado o Curriculum de Franciela Delazeri Carlotto, porém, não foi atendida a recomendação de que o mesmo fosse atualizado. A última atualização do currículo foi em 25/01/2018.

Não foram informadas as atribuições de Franciela Delazeri Carlotto.

As referências bibliográficas não foram corrigidas, conforme recomendação.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Análise das respostas às pendências mencionadas no parecer consubstanciado 6.710.261 de 19/03/2024.

Pendência 1/5 - Incluir, devidamente atualizado, o Curriculum Lattes da Enfermeira Dra. Deise Lisboa Riquinho.

Resposta: Lattes atualizado anexado.

Análise: Pendência atendida

Pendência 2/5 - Como se dará o acesso ao banco do SINAN?

Resposta: Após aprovação do CEP, o banco do SINAN será acessado através de arquivo disponibilizado pela profissional coordenadora da vigilância das doenças transmissíveis e crônicas. O arquivo disponibilizado conterá as variáveis disponíveis e descritas no projeto, dentro do período de tempo delimitado. Alteração disponível na página 17, linha 33.

Análise: Pendência atendida

Pendência 3/5 - Assinar formulário do projeto de pesquisa.

Resposta: Formulário assinado anexada.

Análise: Pendência atendida

Pendência 4/5 - Quando submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, o cronograma deverá estar atualizado. Atentar especialmente para a etapa de coleta de dados, a

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro: Centro Histórico	CEP: 90.010-040		
UF: RS	Município: PORTO ALEGRE		
Telefone: (51)3289-5517	Fax: (51)3289-2453	E-mail: cep_sms@hotmail.com	



**Prefeitura de
Porto Alegre**
Secretaria Municipal de Saúde

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PORTO ALEGRE/
SMSPA**



Continuação do Parecer: 6.757.499

qual deverá ocorrer, necessariamente, somente após a tramitação no CEP SMS/PMPA.

Resposta: cronograma atualizado.

Análise: Pendência atendida

Pendência 5/5 - Como se dará a devolutiva?

Resposta: Os resultados do estudo serão resumidos e discutidos com as equipes da vigilância epidemiológica do município, instâncias gestoras da SMS/POA e Conselho Municipal de Saúde através de reuniões previamente acordadas. Página 19, linha 18.

Análise: Pendência atendida

Considerações Finais a critério do CEP:

O parecer de aprovação do CEP SMSPA deverá ser apresentado à Coordenação responsável, a fim de organizar a inserção da pesquisa no serviço, antes de seu início. Os relatórios semestrais devem ser apresentados ao CEP SMSPA, através de submissão na Plataforma Brasil, como "Notificação".

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2283486.pdf	22/03/2024 08:14:28		Aceito
Brochura Pesquisa	Projeto_mestrado_Coorte_alteracoes_cep_SMSPOA.docx	20/03/2024 14:17:58	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_mestrado_Coorte_alteracoes_cep_SMSPOA.pdf	20/03/2024 14:17:13	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	Formulario_de_Projeto_Pesquisa_CEP_SMSPA.pdf	20/03/2024 14:15:45	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	curriculo_lattes_deiseriquinho.pdf	20/03/2024 14:10:49	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	termo_de_compromisso_dados.pdf	20/03/2024 14:09:40	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	Resposta_parecer_cep_SMSPOA.pdf	20/03/2024 14:08:48	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto.docx	02/02/2024 13:47:00	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	termo.pdf	02/02/2024 13:46:22	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	termodeanuencia3.pdf	19/01/2024	Deise Lisboa	Aceito

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico

CEP: 90.010-040

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517

Fax: (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

 Prefeitura de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSA	
---	--	---

Continuação do Parecer: 6.757.499

Outros	termodeanuencia3.pdf	19:03:47	Riquinho	Aceito
Outros	termoanuencia2.jpeg	19/01/2024 19:03:21	Deise Lisboa Riquinho	Aceito
Outros	termoanuencia1.pdf	19/01/2024 19:02:50	Deise Lisboa Riquinho	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 11 de Abril de 2024

Assinado por:
Alexandre Luis da Silva Ritter
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro: Centro Histórico	CEP: 90.010-040		
UF: RS	Município: PORTO ALEGRE		
Telefone: (51)3289-5517	Fax: (51)3289-2453	E-mail: cep_sms@hotmail.com	